Nomes: Arthur Davi Gomes, Gustavo Silva de Carvalho, Raul Tenorio, Matheus Henrique Vieira Neves

Laboratório de Desenvolvimento Web 2

PI – 6 semestre

Sprint 1: Planejamento

Definição do problema e público-alvo

Problema: Fragmentação do sistema de saúde no Brasil. Cada município contém portais de saúde distintos, que não se conectam, o que torna difícil a troca rápida de exames, prescrições, histórico de operações e condições médicas anteriores dos pacientes, além de resultar em riscos clínicos como alergias não identificadas, e uso inadequado de recursos.

Público-alvo: Pacientes e os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e equipes de atendimento).

Justificativa e objetivos

Justificativa: Integrar os dados de saúde evita a repetição desnecessária de exames, agiliza diagnósticos de emergência e previne erros médicos graves, como reações a medicamentos e desconhecimento de cirurgias prévias. Além disso, centralizar esses dados permite gerar inteligência epidemiológica para embasar políticas públicas assertivas baseadas em regiões.

Objetivos: Criar um ecossistema unificado de saúde que gere economia de dinheiro, recursos e tempo, promovendo a interoperabilidade entre os diversos sistemas médicos existentes no país.

Levantamento inicial de requisitos

Requisitos Funcionais: Cadastro unificado de pacientes integrado com bases nacionais (CPF).

Prontuário eletrônico (histórico de consultas, cirurgias, alergias e laudos de exames).

Repositório centralizado de exames e receitas médicas digitais com validação.

Controle de privacidade para o paciente gerenciar quem acessa seus dados.

Painéis analíticos (dashboards) voltados para gestores públicos mapearem dados de saúde por região.

Requisitos Não-Funcionais: Alta disponibilidade e infraestrutura resiliente em nuvem.

Segurança da informação (criptografia de ponta a ponta e controle de perfis de acesso).

Conformidade total com a LGPD e padrões de saúde.

Definição do escopo

Site: Portal web institucional e de gestão para médicos.

API: Camada de integração robusta e padronizada para conectar sistemas legados de hospitais, clínicas e prefeituras.

App de celular: Aplicativo móvel voltado para o paciente acessar seu histórico, exames e carteira digital de saúde.

Equipe e responsabilidades

Arthur Davi Gomes, Gustavo Silva de Carvalho, Raul Tenorio, Matheus Henrique Vieira Neves

Arquitetura de Software / Dados: Desenho da infraestrutura em nuvem, padrões de APIs de saúde (FHIR) e estratégias de segurança e LGPD.

Backend (APIs e Banco de Dados): Construção dos microsserviços, motores de busca de prontuários e integrações.

Frontend / Mobile: Criação do site web responsivo e do aplicativo móvel (iOS/Android).

Segurança da Informação (Cybersecurity): Blindagem do sistema contra vazamentos e auditoria de acessos.

Metodologia de gestão

Metodologia Ágil (Scrum/Kanban) e Abordagem por MVP (Mínimo Produto Viável)

Cronograma inicial

Sprint 1 - Planejamento (10/09): Concepção, arquitetura de sistemas, definição de padrões de API e desenho de UI/UX.

Sprint 2 - MVP (01/10): Desenvolvimento do MVP (API central + Versão inicial do App e do Site)

Sprint 3 - Versão Beta (22/10): Versão inicial do App e testes de segurança

Sprint 4 - Release Candidate (05/11): Testes de segurança, correções e ajustes de usabilidade

Sprint 5 - Produto Final (19/11): Entrega definitiva do projeto

Organização do repositório

docs/: Documentação de arquitetura, padrões de API, especificação de requisitos e termos de conformidade com a LGPD.

backend/: Código-fonte das APIs de integração, microsserviços e conexão com os padrões de saúde.

web-portal/: Código do site/portal administrativo (React,).

mobile-app/: Código do aplicativo móvel para pacientes (React Native).